

간헐적 자가도뇨(ISC/CIC)는 가늘고 부드러운 도뇨관을 직접 삽입하여 소변을 빼낸 뒤 제거하는 방법으로, 하루에 몇 차례 시행합니다. 방광이 스스로 충분히 비워지지 않을 때 사용합니다. 익히고 나면 몇 분이면 끝나며, 생활이 자유로워지고 신장을 보호할 수 있습니다.

시행 이유

특정 수술 후, **신경인성 방광**, 탈출증, 또는 배출 폐색으로 방광이 완전히 비워지지 않으면 잔뇨가 감염·요실금·신장 손상을 일으킬 수 있습니다. ISC는 **정해진 일정에 따라 방광을 완전히 비워** 이러한 문제를 예방합니다.

유치 도뇨관보다 나은 이유

- 유치(留置) 도뇨관보다 **감염이 훨씬 적습니다**
- **집뇨백이 없어** 도뇨 사이에 아무것도 달고 다니지 않아도 됩니다
- 방광과 신장을 장기적으로 더 잘 보호합니다

처음에는 어렵게 느껴지지만, 대부분의 환자와 보호자는 간호사의 도움으로 빠르게 익힐 수 있습니다.

용어 설명

ISC

간헐적 자가도뇨(ISC/CIC) — 도뇨관을 직접 삽입하여 방광을 비운 뒤 제거하는 방법.

도뇨관

방광에 삽입해 소변을 빼내는 가늘고 부드러운 관.

잔뇨

배뇨 후 방광에 남아 있는 소변.

신경인성 방광

신경 이상으로 방광이 정상적으로 기능하지 못하는 상태.

청결법

손과 주변 부위를 씻는 방법 — 완전 멸균은 아니지만 청결하게 유지합니다.

유치 도뇨관

집뇨백과 함께 계속 삽입해 두는 도뇨관 (ISC로 피할 수 있는 방법).

아픈가요? 대부분 거의 아프지 않습니다 — 최신 도뇨관은 미리 윤활 처리되어 있고 매우 가늘어 가벼운 압박감만 느껴집니다. 처음 몇 번은 약간의 불편감이나 소량의 혈흔이 있을 수 있습니다. 간호사가 자신감이 생길 때까지 단계별로 가르쳐 드립니다.

시행 방법 (청결법)

- 1 손을 씻고 필요한 물품을 준비한 뒤, 삽입 부위를 닦습니다.
- 2 윤활된 도뇨관을 **부드럽게 삽입**하여 소변이 나오면 조금 더 밀어 넣습니다.
- 3 방광이 **완전히 비워질** 때까지 기다린 뒤 도뇨관을 천천히 제거합니다.
- 4 일회용 도뇨관은 **버리고** (재사용형은 안내대로 세척), 손을 씻습니다.

시행 빈도

- 보통 **4-6시간마다** (하루 약 4-6회) — 구체적인 일정은 의료진이 정합니다.
- 거르지 마세요 — 규칙적인 일정이 과도한 방광 충만과 감염을 예방합니다.
- 평소대로 수분을 섭취하고, 필요하면 배뇨량을 기록하세요.

알아두세요

- 깨끗한 화장실 어디서나 시행할 수 있으며, 용품은 휴대하기 편합니다.
- 소변이 약간 탁하거나 세균이 검출될 수 있습니다 — **증상**이 있을 때만 치료합니다.
- 직접 하기 어려운 경우 보호자도 배울 수 있습니다.

다음 증상이 있으면 의료진에게 연락하세요:

- 도뇨관이 들어가지 않거나, 방광이 가득 찬 느낌인데 소변이 거의 나오지 않는 경우
- 발열, 오한, 또는 등·옆구리 통증 (감염 의심)
- 지속적인 **출혈** 또는 심한 통증

기억할 세 가지

1. ISC는 스스로 비워지지 않는 방광을 비워 주어 신장을 보호하고 감염과 요실금을 예방합니다.
2. 청결법으로 규칙적인 일정(보통 4-6시간마다)에 따라 시행하세요. 간호사가 익숙해질 때까지 가르쳐 드립니다.
3. 대부분 통증이 없으며 유치 도뇨관보다 안전합니다. 삽입이 안 되거나, 방광이 비워지지 않거나, 발열이 생기면 즉시 연락하세요.